DARI KRISIS MENUJU TERAPEUTIK: OPTIMALISASI KESELAMATAN PASIEN MELALUI CHECKLIST SAFETY-SAFEWARDS DI RUANG INTENSIF PSIKIATRI LAKI-LAKI RS MUTIARA SUKMA

Karya Lomba Case Solving RSMS 2026

Nama peserta: Nurlela Vodesta, A.Md. Kep.

Unit kerja: Ruang Intensif Psikiatri Laki-laki, Rumah Sakit Mutiara Sukma

1. Latar Belakang

Pelayanan di Ruang Intensif Psikiatri Laki-laki menuntut kesiapsiagaan perawat untuk menjaga keselamatan pasien, pasien lain, dan petugas, sekaligus mempertahankan pendekatan yang humanis dan terapeutik. Perubahan perilaku, kecemasan, peningkatan ketegangan, penolakan, atau pemicu lingkungan dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak dikenali dan direspons sejak dini. Karena itu, keselamatan perlu dibangun melalui pencegahan, komunikasi terapeutik, konsistensi respons tim, dan evaluasi bukan hanya melalui respons ketika krisis terjadi.

Data indikator mutu yang dicantumkan dalam bahan peserta menunjukkan capaian indikator “Tidak Ada Pasien yang Difiksasi Lebih dari 4 Jam” sebesar 86,1% pada 2023 dan 82% pada 2024, kemudian 100% pada 2025 serta Januari–September 2026. Capaian tersebut perlu dipertahankan, tetapi tidak membuktikan bahwa seluruh risiko atau insiden telah teratasi maupun bahwa satu intervensi tertentu menyebabkan perbaikan.

Rekap insiden ruangan mencatat 55 insiden pada 2025 dan 28 insiden pada Januari–Juni 2026. Perbandingan periode yang sama menunjukkan 23 insiden pada Januari–Juni 2025 dan 28 pada Januari–Juni 2026. Data agregat ini menjadi sinyal untuk meninjau pola insiden dan proses pencegahannya, tetapi belum menjelaskan jenis, keparahan, pemicu, atau penyebab kejadian.

Sebagai perawat ruang intensif laki-laki, peserta mengusulkan Checklist Safety-Safewards: alat bantu ringkas untuk mengingatkan deteksi dini, respons terapeutik, komunikasi/escalation, dokumentasi, dan serah terima. Checklist harus divalidasi terhadap SOP RSMS dan tidak menggantikan asesmen klinis atau formulir resmi.

2. Identifikasi dan Dampak Masalah

a. Rumusan masalah

Bagaimana memperkuat konsistensi proses pencegahan insiden dan keselamatan pasien di Ruang Intensif Psikiatri Laki-laki melalui checklist sederhana yang terintegrasi ke alur kerja perawat, dapat diaudit, dan tetap berorientasi terapeutik?

b. Rekap data insiden

Rekap bulanan yang diberikan peserta dirangkum sebagai berikut. Jumlah 2026 hanya mencakup Januari–Juni, sehingga tidak dibandingkan sebagai total tahunan dengan 2025.

Bulan	2025	2026
Januari	4	7
Februari	7	3
Maret	2	1
April	2	1
Mei	4	9
Juni	4	7
Juli	7	—
Agustus	3	—
September	7	—
Oktober	4	—
November	5	—
Desember	6	—
Total	55	28

Total Januari–Juni 2025 adalah 23 insiden, sedangkan Januari–Juni 2026 adalah 28 insiden: bertambah 5 insiden atau sekitar 21,7%. Jumlah tertinggi pada 2025 adalah 7 insiden pada Februari, Juli, dan September; pada Januari–Juni 2026, jumlah tertinggi adalah 9 pada Mei. Interpretasi perbandingan mengasumsikan definisi insiden, cara pencatatan, dan kelengkapan pelaporan sama.

c. Dampak dan masalah proses

1) Pasien: tanda awal eskalasi atau kebutuhan dukungan berpotensi terlambat dikenali apabila informasi penting tidak terstruktur atau tidak tersampaikan.
2) Perawat/tim: respons dapat tidak konsisten bila informasi tentang pemicu, pendekatan yang membantu, dan tindak lanjut tidak dikomunikasikan.
3) Unit/rumah sakit: dokumentasi proses yang tidak lengkap dapat menyulitkan pembelajaran insiden dan evaluasi mutu.

3. Analisis Akar Masalah

Berikut merupakan kerangka validasi melalui audit laporan insiden, observasi alur, telaah SOP, dan diskusi tim

Aspek proses	Pertanyaan validasi	Bukti yang perlu dikumpulkan
Deteksi dini	Apakah perubahan kondisi/tanda ketegangan dikenali dan ditindaklanjuti sesuai prosedur?	Audit laporan insiden dan dokumentasi
Komunikasi	Apakah pemicu, pendekatan yang membantu, perubahan kondisi, dan tindak lanjut disampaikan antarpetugas?	Audit serah terima yang diizinkan
Dokumentasi	Apakah pengamatan, tindakan, respons, eskalasi, dan evaluasi tercatat tepat waktu?	Audit sampel dokumen resmi
Kompetensi/dukungan	Apakah petugas membutuhkan penyegaran komunikasi terapeutik atau deeskalasi?	Umpan balik/briefing/simulasi
Lingkungan/kegiatan	Apakah waktu, aktivitas, kepadatan, kebisingan, atau kondisi lingkungan berkaitan dengan kategori insiden tertentu?	Analisis kategori dan konteks insiden
Pembelajaran	Apakah dilakukan evaluasi setelah insiden dan tindak lanjutnya dipantau?	Catatan tindak lanjut dan rapat mutu

4. Alternatif Solusi

a. Briefing/penyegaran Safewards: memperkuat pemahaman tim, tetapi perlu penguatan berulang dan pemantauan penerapan.
b. Perbaikan serah terima: membantu kesinambungan informasi, tetapi tidak selalu mengingatkan proses selama shift.
c. Checklist Safety-Safewards: menghubungkan deteksi dini, komunikasi terapeutik, eskalasi, dokumentasi, dan serah terima dalam alat bantu singkat; dapat diuji coba dengan biaya rendah.

5. Rancangan Checklist Safety-Safewards

Butir proses yang diperiksa	Pertanyaan pengingat
Deteksi dini	Apakah perubahan kondisi atau tanda ketegangan yang relevan diamati dan dikomunikasikan sesuai prosedur?
Pendekatan terapeutik	Apakah kebutuhan pasien didengarkan dan komunikasi dilakukan secara tenang, jelas, serta tidak mengancam bila relevan?
Respons/escalation	Apakah temuan yang memerlukan respons disampaikan kepada petugas berwenang tanpa menunda tindakan keselamatan?

Dokumentasi	Apakah pemantauan, tindakan, respons, dan evaluasi dicatat pada dokumen resmi yang berlaku?
Serah terima	Apakah perubahan kondisi, pendekatan yang membantu, dan tindak lanjut yang belum selesai disampaikan ke shift berikutnya?
Lingkungan/kegiatan	Apakah faktor lingkungan atau kegiatan yang relevan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai kebijakan unit?
Evaluasi insiden	Bila terjadi insiden, apakah pelaporan dan tindak lanjut dilakukan sesuai mekanisme resmi?

a. Cara penggunaan
    1) Sebelum kegiatan/awal pemantauan, perawat menilai kesesuaian kegiatan dengan kondisi dan rencana perawatan serta memeriksa keamanan lingkungan sesuai SOP.
    2) Selama pelayanan, petugas mengamati perubahan kondisi, menggunakan komunikasi yang menghormati pasien, dan melakukan eskalasi sesuai prosedur jika diperlukan.
    3) Setelah kegiatan/kejadian, petugas melengkapi checklist sesuai alur yang disetujui, mencatat pada dokumentasi resmi, dan menyampaikan tindak lanjut saat serah terima.
    4) Koordinator yang ditunjuk meninjau kelengkapan checklist secara agregat, membahas hambatan, dan mengusulkan revisi berdasarkan bukti.
b. Batasan dan mitigasi risiko
    1) Checklist tidak menggantikan asesmen, SOP, instruksi klinis, atau dokumentasi resmi dan tidak boleh menjadi dasar otomatis untuk restrain/seklusi.
    2) Tindakan keselamatan dan eskalasi didahulukan; pengisian tidak boleh menunda pertolongan.
    3) Akses dan penyimpanan mengikuti kebijakan RSMS; laporan lomba hanya memuat data agregat tanpa identitas pasien.
    4) Checklist dibuat ringkas untuk mencegah duplikasi dan beban dokumentasi berlebihan.

6. Rencana Implementasi

Tahap	Kegiatan	Penanggung jawab	Keluaran
1. Pemetaan awal	Tinjau SOP/formulir; telaah kategori insiden dan audit sampel yang diizinkan; catat baseline secara agregat.	Peserta bersama kepala ruangan/ketua tim dan pihak terkait	Ringkasan baseline; daftar kategori prioritas
2.Validasi akar masalah	Identifikasi pola yang didukung bukti dan tentukan proses yang perlu diperbaiki.	Tim kecil yang disepakati	Akar masalah tervalidasi
3. Desain checklist	Susun butir ringkas dan cocokkan dengan dokumentasi serta alur eskalasi resmi.	Peserta dan tim unit	Draf checklist
4. Persetujuan	Tinjau aspek klinis, keselamatan, privasi, duplikasi, dan kelayakan penggunaan.	Kepala ruangan/pihak berwenang sesuai tata kelola RSMS	Persetujuan atau catatan revisi
5. Orientasi	Jelaskan tujuan, cara penggunaan, batasan, dan tindakan jika ada temuan risiko.	Penanggung jawab yang ditunjuk	Bukti briefing/orientasi
6. Uji coba terbatas	Uji pada periode/shift yang disetujui; pantau kelengkapan, waktu pengisian, dan umpan balik.	Perawat pada shift yang disepakati	Data uji coba dan umpan balik
7. Evaluasi	Bandingkan indikator proses sebelum dan selama uji coba; putuskan revisi atau kelanjutan.	Tim unit bersama pihak mutu terkait	Ringkasan evaluasi dan tindak lanjut

7. Indikator Keberhasilan

Target numerik ditetapkan setelah baseline dikumpulkan dan disepakati oleh penanggung jawab unit. Definisi, metode, dan periode pengukuran harus sama saat membandingkan kondisi sebelum dan selama uji coba.

Indikator	Definisi/cara ukur	Baseline	Target/periode
Kelengkapan checklist	Checklist lengkap ÷ checklist yang seharusnya diisi × 100%.	Diukur sebelum/saat awal uji coba	Ditetapkan setelah baseline
Dokumentasi faktor/pemicu relevan	Sampel dokumentasi yang mencatat faktor relevan sesuai kriteria ÷ seluruh sampel audit × 100%.	Audit awal	Ditetapkan setelah baseline
Tindak lanjut/eskalasi	Temuan yang memerlukan tindak lanjut dan tercatat/terkomunikasikan sesuai prosedur ÷ seluruh temuan yang memerlukan tindak lanjut × 100%.	Audit awal	Ditetapkan setelah baseline
Kelengkapan serah terima	Sampel serah terima yang mencakup informasi risiko dan tindak lanjut sesuai kriteria ÷ seluruh sampel yang diaudit × 100%.	Audit awal	Ditetapkan setelah baseline
Kelayakan checklist	Umpan balik petugas mengenai kejelasan, kemudahan, waktu pengisian, dan duplikasi.	Belum diukur	Kriteria disepakati
Jumlah/kategori insiden	Pantau jumlah dan kategori pada sistem resmi; bandingkan periode sama serta telaah kelengkapan pelaporan.	2025: 55; Jan–Jun 2025: 23; Jan–Jun 2026: 28	Pantau tren; tidak menyimpulkan sebab-akibat dari jumlah saja
Indikator fiksasi >4 jam	Gunakan definisi dan sumber resmi Komite Mutu; verifikasi angka pada laporan asli.	Bahan peserta: 2023 86,1%; 2024 82%; 2025 100%; Jan–Sep 2026 100%.	Pertahankan target resmi; interpretasikan terpisah dari jumlah insiden

8. Kesimpulan

Rekap yang diberikan mencatat 55 insiden pada 2025 dan 28 insiden pada Januari–Juni 2026. Periode Januari–Juni meningkat dari 23 insiden pada 2025 menjadi 28 pada 2026. Data ini menjadi alasan untuk meninjau proses pencegahan dan pembelajaran, tetapi belum menjelaskan jenis atau penyebab insiden. Data indikator fiksasi lebih dari empat jam yang tercantum dalam bahan peserta harus diverifikasi dari laporan resmi dan dianalisis terpisah.

Checklist Safety-Safewards diusulkan untuk memperkuat konsistensi deteksi dini, komunikasi terapeutik, eskalasi, dokumentasi, dan serah terima. Keberhasilan akan dinilai melalui indikator proses, kelayakan penggunaan, serta pemantauan tren insiden dengan metode yang konsisten. Penerapan baru dilakukan setelah validasi SOP dan uji coba terbatas; hasil tidak boleh diklaim sebelum benar-benar diukur.

Referensi

RS Mutiara Sukma. Laporan Komite Mutu: indikator “Tidak Ada Pasien yang Difiksasi Lebih dari 4 Jam”, 2023–September 2026.

LAMPIRAN 1. CONTOH CHECKLIST SAFETY-SAFEWARDS

Rancangan untuk validasi internal. Bukan formulir klinis yang telah disahkan dan tidak menggantikan asesmen atau dokumentasi resmi.

Butir proses (sesuai SOP)	Ya	Tidak/belum	Tidak relevan	Catatan/tindak lanjut pada sistem resmi
Perubahan kondisi/tanda ketegangan diamati sesuai prosedur	☐	☐	☐	
Informasi relevan dikomunikasikan kepada tim/petugas berwenang	☐	☐	☐	
Pendekatan komunikasi terapeutik diupayakan bila relevan	☐	☐	☐	
Temuan yang memerlukan respons dieskalasikan tanpa penundaan	☐	☐	☐	
Pemantauan, tindakan, respons dicatat pada dokumen resmi	☐	☐	☐	
Risiko relevan dan tindak lanjut diserahterimakan	☐	☐	☐	
Faktor lingkungan/kegiatan relevan diperiksa sesuai kebijakan	☐	☐	☐	
Pelaporan dan tindak lanjut insiden dilakukan sesuai prosedur bila ada kejadian	☐	☐	☐	

Tanggal/shift/petugas: diisi pada formulir resmi sesuai kebijakan unit.

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI KEGIATAN DI RUANG INTENSIF PSIKIATRI LAKI-LAKI



Foto 1. Pengarahan atau aktivitas kelompok soft word



Foto 2. Kegiatan kelompok dengan reasurance



Foto 3. Pertemuan kelompok dengan matual help meting



Foto 4. Beribadah bersama